

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 1517.1/I-KEP/DIR/XII/2024**

**TENTANG
PERATURAN INTERNAL TENAGA MEDIS
(MEDICAL BY-LAWS)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*) serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai hubungan, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran dan tenaga kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian tata kelola Tenaga medis guna menjamin kepastian hukum, profesionalisme, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Internal Tenaga medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Prima Husada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PERATURAN INTERNAL TENAGA MEDIS (MEDICAL STAF BYLAWS)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Peraturan Internal Tenaga medis (Medical Staff By Laws) ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rumah Sakit adalah Rumah sakit prima husada yang dikelola oleh PT Disa Prima Medika sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi operasional rumah sakit yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
- (3) Komisaris Utama adalah organ Perseroan yang menetapkan kebijakan strategis dan pengawasan umum terhadap rumah sakit.
- (4) Komite Medik adalah perangkat rumah sakit yang berfungsi membantu Direktur dalam pengelolaan standar profesi, kredensial, dan mutu pelayanan medis.
- (5) Tenaga Medis adalah dokter dan/atau dokter gigi yang memiliki Surat Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) di Rumah Sakit.
- (6) Kelompok Tenaga medis (KSM) adalah pengelompokan tenaga medis berdasarkan disiplin ilmu atau bidang pelayanan tertentu dalam rumah sakit.
- (7) Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus yang diberikan kepada tenaga medis untuk melakukan tindakan medis tertentu di rumah sakit berdasarkan hasil kredensial.
- (8) Surat Penugasan Klinis (SPK) adalah dokumen resmi yang ditetapkan oleh Direktur sebagai dasar legal pelaksanaan kewenangan klinis di rumah sakit.
- (9) Rekam Medis Elektronik (eRM) adalah sistem pencatatan data pasien secara elektronik yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- (10) Kredensial adalah proses evaluasi terhadap kompetensi, kualifikasi, dan kelayakan tenaga medis untuk diberikan kewenangan klinis.
- (11) Rekredensial adalah proses evaluasi ulang secara berkala terhadap kewenangan klinis tenaga medis.
- (12) Peer Review adalah penilaian kinerja profesional tenaga medis oleh sejawat profesi.
- (13) Audit Medis adalah evaluasi sistematis terhadap mutu pelayanan medis berdasarkan standar profesi dan standar pelayanan.
- (14) OPPE (Ongoing Professional Practice Evaluation) adalah evaluasi berkala terhadap kinerja dan kompetensi tenaga medis dalam praktik klinis berkelanjutan.
- (15) FPPE (Focused Professional Practice Evaluation) adalah evaluasi terfokus terhadap tenaga medis pada kondisi tertentu atau pada awal pemberian kewenangan klinis.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Peraturan ini mengatur seluruh aspek tata kelola tenaga medis di Rumah Sakit Prima Husada.
- (2) Ruang lingkup meliputi pengorganisasian tenaga medis, kredensial, kewenangan klinis, evaluasi kinerja, etika profesi, serta hubungan kerja dengan manajemen rumah sakit.
- (3) Peraturan ini menjadi dasar hukum internal bagi seluruh tenaga medis dalam melaksanakan praktik kedokteran di rumah sakit.

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

- (1) Penyelenggaraan tata kelola klinis yang baik melalui mekanisme kredensial yang ketat

- (2) Peningkatan mutu profesi secara berkelanjutan demi keselamatan pasien
- (3) Penegakan disiplin profesi medis untuk menjaga standar etika dan praktik kedokteran
- (4) Penciptaan kerja sama yang harmonis antara seluruh tenaga medis dengan Direktur Rumah Sakit
- (5) Perwujudan sinergisme antara manajemen operasional dan profesi medis untuk kepentingan terbaik pasien
- (6) Penumbuhan rasa tanggung jawab tenaga medis terhadap kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit
- (7) Pengaturan hak dan kewajiban profesional dalam menjalankan tugas klinis sehari-hari
- (8) Dasar hukum internal dalam penyelesaian konflik atau masalah perilaku profesi

Pasal 4

Kredensial dan Rekredensial Tenaga Medis

- (1) Rumah Sakit menyelenggarakan proses kredensial dan rekredensial bagi seluruh tenaga medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kompetensi, kewenangan klinis, perilaku profesional, kesehatan fisik dan mental, serta kelayakan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- (3) Pemberian, perubahan, pembatasan, perpanjangan, atau pencabutan kewenangan klinis tenaga medis dilakukan berdasarkan hasil proses kredensial dan rekredensial.
- (4) Dalam proses kredensial dan rekredensial, Rumah Sakit melakukan verifikasi terhadap dokumen pendidikan, registrasi, perizinan, sertifikasi kompetensi, pengalaman profesional, serta dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (5) Tenaga medis yang mengajukan kewenangan klinis baru wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kredensial, rekredensial, dan kewenangan klinis diatur dalam peraturan internal Rumah Sakit.
- (7) Rekredensial dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun serta dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Rumah Sakit, termasuk dalam hal adanya penambahan, perubahan, pengurangan, atau penghentian penugasan tenaga medis dan/atau perubahan kewenangan klinis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kredensial, rekredensial, dan kewenangan klinis diatur dalam peraturan internal Rumah Sakit.

Pasal 5

Evaluasi Kinerja dan Ongoing Professional Practice Evaluation (OPPE)

- (1) Rumah Sakit melaksanakan evaluasi kinerja tenaga medis secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap perilaku profesional, pengembangan profesional berkelanjutan, dan kinerja klinis.
- (3) Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (Ongoing Professional Practice Evaluation/OPPE) dilaksanakan secara periodik untuk menilai kompetensi dan kinerja tenaga medis dalam menjalankan kewenangan klinis yang diberikan.
- (4) Dalam hal diperlukan, Rumah Sakit dapat melaksanakan Evaluasi Praktik Profesional Terfokus (Focused Professional Practice Evaluation/FPPE) terhadap tenaga medis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hasil evaluasi kinerja, OPPE, dan FPPE digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses rekredensial, pemberian kewenangan klinis, pengembangan kompetensi, serta tindak lanjut pembinaan tenaga medis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi kinerja, OPPE, dan FPPE diatur dalam peraturan internal Rumah Sakit.

BAB II
KEWENANGAN KLINIS
(CLINICAL PRIVILEGE)

Pasal 6
Kewenangan Klinis

- (1) Pelaksanaan seluruh pelayanan medis hanya oleh staf yang telah memiliki otoritas resmi dari Direktur Rumah Sakit.
- (2) Kewajiban penandatanganan perjanjian kerja sama bagi setiap tenaga medis sesuai regulasi internal yang berlaku.
- (3) Pemberian kewenangan klinis dalam bentuk dokumen Surat Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK).
- (4) Penetapan kewenangan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi formal dari Komite Medik melalui Subkomite Kredensial.
- (5) Penerapan prosedur penerimaan anggota SMF yang ketat sebagai dasar pemberian izin praktik internal.
- (6) Masa berlaku kewenangan klinis bagi setiap anggota SMF untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
- (7) Proses pemberian kewenangan klinis ulang melalui mekanisme rekredensial oleh Subkomite Kredensial Komite Medik.
- (8) Penjaminan standar kompetensi medis yang mutakhir melalui evaluasi kualifikasi secara berkala.

Pasal 7
Proses Penilaian Kewenangan Klinis

- (1) Status kelulusan dari institusi pendidikan kedokteran yang telah terakreditasi secara resmi.
- (2) Penyelesaian seluruh jenjang program pendidikan kedokteran sesuai dengan spesialisasi.
- (3) Kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang profesi.
- (4) Kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP) aktif dari Dinas Kesehatan setempat.
- (5) Keanggotaan aktif dalam organisasi profesi yang menyelenggarakan penilaian kompetensi berkala.
- (6) Partisipasi nyata dalam setiap proses evaluasi mutu klinis dan audit medis di rumah sakit.
- (7) Rekam jejak disiplin dan kepatuhan terhadap kode etik profesi yang bersih.
- (8) Keanggotaan dalam perhimpunan profesi spesialis yang diakui secara nasional.
- (9) Kondisi kesehatan jasmani dan mental yang prima untuk menjamin kualitas pelayanan pasien.
- (10) Pernyataan bebas dari penggunaan obat terlarang serta alkohol yang dapat mengganggu tugas.
- (11) Riwayat perilaku profesional yang bersih dari tindakan kekerasan atau pelecehan.
- (12) Kepemilikan asuransi proteksi profesi sebagai perlindungan hukum dalam praktik medis.
- (13) Rekam jejak pengalaman praktik di berbagai fasilitas kesehatan sebelumnya.
- (14) Riwayat penanganan tuntutan medis atau klaim dari pasien selama menjalankan profesi.

Pasal 8
Pembatasan Kewenangan Klinis

- (1) Pemberian rekomendasi pembatasan kewenangan oleh Komite Medik kepada Direktur berdasarkan keputusan Subkomite Kredensial.



- (2) Pertimbangan pembatasan akibat pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medis dan prosedur operasional.
- (3) Penilaian pelanggaran dari sudut pandang kinerja klinik, etika profesi, disiplin medis, maupun aspek hukum.
- (4) Pengajuan surat permohonan peninjauan kewenangan dari Ketua SMF kepada Ketua Komite Medik sebagai langkah awal.
- (5) Penerusan berkas permohonan kepada Subkomite Kredensial untuk pemeriksaan mendalam terhadap personel yang bersangkutan.
- (6) Hak anggota SMF untuk mendapatkan informasi mengenai bukti tertulis atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan.
- (7) Hak anggota SMF untuk menghadiri pemanggilan resmi guna memberikan penjelasan serta melakukan pembelaan diri.
- (8) Kewenangan Subkomite Kredensial untuk meminta pendapat ahli atau pihak eksternal terkait dalam proses pengambilan keputusan.
- (9) Penerbitan rekomendasi final yang objektif demi menjaga keselamatan pasien dan mutu layanan rumah sakit.

Pasal 9

Pencabutan Kewenangan Klinis

- (1) Pelaksanaan pencabutan kewenangan secara resmi oleh Direktur Rumah Sakit.
- (2) Penetapan keputusan berdasarkan rekomendasi bersama dari Komite Medik.
- (3) Proses pengusulan melalui evaluasi Sub komite Etika dan Disiplin Profesi serta Subkomite Kredensial.
- (4) Pertimbangan pencabutan akibat adanya gangguan kesehatan fisik maupun mental yang menghambat tugas.
- (5) Penindakan atas kejadian kecelakaan medis yang diduga kuat terjadi karena inkompetensi tenaga medis.
- (6) Pemberian sanksi pencabutan bagi staf yang mendapatkan tindakan disiplin berat dari Komite Medik.
- (7) Perlindungan keselamatan pasien melalui penghentian sementara atau tetap hak praktik klinis.
- (8) Prosedur administrasi yang selaras dengan kebijakan tata kelola klinis rumah sakit.

Pasal 10

Pengakhiran Kewenangan Klinis

- (1) Pelaksanaan pengakhiran kewenangan secara resmi oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi Komite Medik.
- (2) Proses pengusulan melalui koordinasi antara Subkomite Etika dan Disiplin Profesi serta Subkomite Kredensial.
- (3) Pengakhiran kewenangan secara otomatis apabila masa berlaku Surat Penugasan Klinis (SPK) telah habis.
- (4) Pencabutan kewenangan klinis sebagai tindak lanjut atas pelanggaran sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
- (5) Penghentian hak pelayanan medis apabila masa berlaku Perjanjian Kerja Sama antara tenaga medis dan rumah sakit telah berakhir.
- (6) Peninjauan kembali status kewenangan klinis dalam rangka pembaruan kontrak atau proses rekredensial.
- (7) Penertiban administrasi profesi untuk menjamin setiap tindakan medis didasarkan pada izin yang masih aktif.

BAB III PENUGASAN KLINIS

Pasal 11

- (1) Surat Penugasan Klinis (SPK) adalah Kewajiban kepemilikan Surat Penugasan Klinis bagi setiap tenaga medis dalam melaksanakan seluruh asuhan medis.
- (2) Penerbitan dokumen resmi oleh Direktur Rumah Sakit sebagai dasar legalitas praktik internal.
- (3) Penyusunan isi surat berdasarkan Rincian Kewenangan Klinis yang direkomendasikan secara spesifik oleh Komite Medik.
- (4) Penentuan status keanggotaan tenaga medis dalam organisasi rumah sakit melalui kepemilikan surat tersebut.
- (5) Larangan melakukan pelayanan medis bagi staf yang tidak memiliki atau belum mendapatkan Surat Penugasan Klinis.
- (6) Jaminan keamanan bagi pasien bahwa setiap tindakan medis dilakukan oleh tenaga yang memiliki izin sah.
- (7) Pengendalian mutu pelayanan melalui validasi berkala terhadap status penugasan klinis setiap anggota.

BAB IV PERATURAN TATA KELOLA KLINIS

Pasal 12

- (1) Penerapan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional secara konsisten dalam setiap pelayanan medis.
- (2) Pemberian asuhan medis yang berorientasi sepenuhnya pada kebutuhan klinis dan keselamatan pasien.
- (3) Kewajiban melakukan konsultasi antar sejawat guna memastikan ketepatan penanganan medis.
- (4) Pelaksanaan rujukan pasien kepada dokter atau dokter spesialis dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan kondisi pasien.
- (5) Kewajiban melakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap seluruh jaringan yang dikeluarkan dari tubuh manusia.
- (6) Penerapan pengecualian pemeriksaan jaringan tertentu sesuai dengan protokol medis yang ditetapkan.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola klinis yang disiplin di luar ketentuan umum peraturan internal rumah sakit.
- (8) Penjaminan mutu praktik kedokteran melalui kepatuhan terhadap norma dan etika profesi yang berlaku.

BAB V TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL TENAGA MEDIS

Pasal 13

- (1) Penyesuaian isi peraturan berdasarkan adanya perubahan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mendasari.
- (2) Pelaksanaan tinjauan ulang dan perubahan dokumen secara berkala dengan jangka waktu maksimal setiap 3 (tiga) tahun.



- (3) Tanggung jawab teknis proses perubahan peraturan berada di bawah kendali Komite Medik Rumah Sakit.
- (4) Pelibatan aktif seluruh tenaga medis dan unsur manajemen terkait dalam proses perumusan perubahan.
- (5) Penyelenggaraan lokakarya sebagai wadah diskusi dan sinkronisasi sebelum penetapan aturan baru.
- (6) Pengesahan akhir seluruh perubahan peraturan melalui keputusan resmi Direktur Rumah Sakit.
- (7) Penjaminan relevansi aturan internal dengan perkembangan ilmu kedokteran dan standar pelayanan terkini.

BAB VI TENAGA MEDIS

Pasal 14

- (1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lini rumah sakit
- (2) Pengembangan kualitas pendidikan dan pelatihan medis bagi tenaga kesehatan.
- (3) Penciptaan pola kerja sama yang harmonis antara tenaga medis, pemilik rumah sakit, dan jajaran Direksi.
- (4) Perwujudan sinergi strategis antara manajemen operasional dan profesi medis demi kepentingan terbaik pasien.
- (5) Penguatan tanggung jawab kolektif tenaga medis terhadap standar mutu pelayanan klinis.
- (6) Penjaminan akuntabilitas tenaga medis dalam pelaksanaan program pendidikan di lingkungan rumah sakit.
- (7) Sinkronisasi visi organisasi untuk mencapai target kinerja rumah sakit yang efektif dan efisien.

Pasal 15

Tanggung Jawab Tenaga medis

- (1) Pemberian rekomendasi kepada Direktur melalui Komite Medik terkait permohonan penempatan dokter baru maupun penempatan ulang.
- (2) Penyediaan masukan klinis yang objektif sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Direktur mengenai status kepegawaian medis.
- (3) Pelaksanaan evaluasi kinerja praktik dokter secara berkala dengan menggunakan data pelayanan yang komprehensif.
- (4) Fasilitasi dan pemberian kesempatan bagi tenaga medis untuk mengikuti program pengembangan profesi berkelanjutan.
- (5) Pemberian saran serta pertimbangan strategis kepada manajemen terkait seluruh aspek praktik kedokteran di rumah sakit.
- (6) Pelaporan hasil pemantauan indikator mutu klinik secara rutin kepada Direktur melalui Ketua Komite Medis.
- (7) Penyerahan hasil evaluasi kinerja klinis dan progres program pengembangan staf sebagai bentuk akuntabilitas.
- (8) Pelaksanaan pembaruan secara berkala terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dokumen pendukung layanan medis.
- (9) Penjaminan relevansi standar prosedur dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terkini.

Pasal 16

Proses Penerimaan, Pengangkatan Tenaga medis dan Pengangkatan Kembali Staf Medis

- (1) Pelaksanaan prosedur penerimaan, pengangkatan, dan pengangkatan kembali tenaga medis secara tertib administrasi.
- (2) Penilaian kompetensi calon tenaga medis yang mengacu pada standar kebijakan internal rumah sakit.
- (3) Penyesuaian kualifikasi tenaga medis dengan karakteristik dan populasi pasien yang dilayani.
- (4) Keselarasan proses pengangkatan staf dengan misi serta visi besar rumah sakit.
- (5) Penjaminan ketersediaan pelayanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan medis pasien secara optimal.
- (6) Konsistensi penerapan aturan rekrutmen terhadap standar pelayanan yang diberikan rumah sakit.
- (7) Pemenuhan persyaratan kualifikasi profesional guna menjaga kualitas dan keamanan layanan kesehatan.

Pasal 17

Kategori Tenaga medis

- (1) Tenaga medis Tetap merupakan dokter yang terikat secara penuh waktu dan berkelanjutan di rumah sakit.
- (2) Tenaga medis Paruh Waktu merupakan dokter yang memberikan pelayanan berdasarkan jadwal atau kontrak waktu tertentu.
- (3) Dokter Tamu merupakan tenaga medis ahli dari luar organisasi yang diundang untuk pelayanan atau konsultasi spesifik.
- (4) Dokter Umum Unit Gawat Darurat merupakan tenaga medis yang bertugas khusus menangani kasus kegawatdaruratan medis.
- (5) Dokter Umum Pelayanan Intensif merupakan tenaga medis yang berfokus pada asuhan pasien di unit perawatan kritis.
- (6) Komite Medik merupakan perangkat rumah sakit yang berfungsi sebagai wadah profesional bagi seluruh tenaga medis.
- (7) Wadah Profesional Medis merupakan struktur organisasi internal yang menaungi koordinasi serta disiplin profesi kedokteran.

Pasal 18

Dokter Tetap

- (1) Status kepegawaian dokter yang direkrut secara resmi oleh Rumah sakit prima husada sebagai pegawai tetap.
- (2) Kedudukan dokter sebagai subordinat yang bekerja secara profesional untuk dan atas nama rumah sakit.
- (3) Tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada jajaran Direksi Rumah Sakit.
- (4) Pemenuhan kualifikasi profesional yang ketat sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing.
- (5) Pelaksanaan hak dan kewajiban dokter yang diatur secara spesifik dalam ketentuan internal organisasi.
- (6) Kepatuhan terhadap seluruh standar dan regulasi yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Penjaminan stabilitas pelayanan medis melalui komitmen kerja jangka panjang di rumah sakit.



Pasal 19
Dokter Tamu

- (1) Penugasan tenaga medis yang diundang secara khusus oleh rumah sakit karena reputasi atau keahlian tertentu.
- (2) Penanganan kasus medis kompleks yang berada di luar kapasitas atau kemampuan tenaga medis fungsional yang tersedia.
- (3) Pemberian bantuan konsultatif atau tindakan medis pada situasi yang membutuhkan keahlian sub-spesialistik.
- (4) Demonstrasi dan penerapan teknologi medis baru sebagai bagian dari pembaruan layanan di rumah sakit.
- (5) Penguatan mutu pelayanan klinis melalui transfer pengetahuan kepada tenaga medis internal.
- (6) Pemberian izin praktik khusus sesuai dengan prosedur kredensial bagi dokter tamu yang telah ditetapkan.
- (7) Kontribusi profesional yang bersifat temporer sesuai dengan kebutuhan spesifik penanganan pasien.

Pasal 20
Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat

- (1) Pemberian pelayanan medis kedaruratan di unit gawat darurat sesuai dengan penempatan resmi dari rumah sakit.
- (2) Pelaksanaan tugas klinis yang didelegasikan secara spesifik oleh manajemen rumah sakit.
- (3) Pemenuhan kualifikasi profesional yang ketat sesuai dengan standar kompetensi dokter umum di bidang kegawatdaruratan.
- (4) Penggunaan hak profesional dalam memberikan asuhan medis yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (5) Pemenuhan kewajiban profesi yang diatur melalui ketentuan internal khusus dan regulasi rumah sakit.
- (6) Kepatuhan penuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kedokteran.
- (7) Penjaminan respons medis yang cepat dan akurat sebagai garda terdepan pelayanan pasien di rumah sakit.

Pasal 21
Dokter Umum di Ruang Rawat Inap

- (1) Pemberian pelayanan asuhan medis secara berkesinambungan bagi pasien di instalasi rawat inap.
- (2) Pelaksanaan tugas klinis sesuai dengan instruksi dan penempatan resmi dari pihak manajemen rumah sakit.
- (3) Pemenuhan standar kualifikasi tenaga medis yang kompeten dalam pengelolaan pasien rawat inap.
- (4) Kewajiban menjalankan praktik kedokteran yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemantauan kondisi klinis pasien secara rutin untuk menjamin stabilitas kesehatan selama masa perawatan.
- (6) Koordinasi aktif dengan tenaga medis lainnya dalam rangka optimalisasi rencana terapi pasien.
- (7) Penjaminan dokumentasi medis yang akurat dan lengkap pada rekam medis pasien rawat inap.

Pasal 22 Pembinaan

- (1) Penyampaian laporan kejadian oleh tenaga medis kepada Ketua Kelompok, Komite Medis, dan Direktur atau Kabid Pelayanan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi informasi oleh Ketua Kelompok kepada pihak terkait guna menjaga martabat profesi dan objektivitas data.
- (3) Pengaktifan mekanisme audit medis oleh Komite Medis melalui kerja sama dengan Direktur untuk pengumpulan data lintas unit.
- (4) Koordinasi pengumpulan data penunjang dari unsur keperawatan, laboratorium, radiologi, hingga regu jaga yang bertugas.
- (5) Penyelenggaraan rapat klinik multidisiplin segera setelah data dinyatakan lengkap untuk analisis kasus secara mendalam.
- (6) Penajaman kajian terhadap diagnosis, prosedur pelayanan, serta ketepatan tindakan dan pengobatan dalam rapat klinik.
- (7) Pemanfaatan hasil rapat klinik sebagai bahan evaluasi utama untuk perbaikan mutu pelayanan medis di masa depan.
- (8) Penerapan sanksi profesional atau administratif secara hati-hati dan objektif berdasarkan hasil temuan audit.
- (9) Pengelolaan informasi hasil rapat secara internal untuk menjaga kerahasiaan medis dan integritas rumah sakit.

Pasal 23

Pengorganisasian Tenaga medis

- (1) Kewajiban bagi seluruh dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis baik purna waktu maupun paruh waktu untuk menjadi anggota tenaga medis resmi.
- (2) Pengelompokan tenaga medis berdasarkan spesialisasi atau keahlian tertentu guna menunjang efektivitas pelayanan.
- (3) Ketentuan minimal jumlah anggota setiap kelompok tenaga medis adalah sebanyak 2 (dua) orang dokter.
- (4) Pembentukan kelompok tenaga medis tunggal bagi tenaga dokter yang memiliki bidang spesialisasi atau keahlian yang sama.
- (5) Kebijakan penggabungan beberapa dokter spesialis yang berbeda bidang keahlian apabila jumlah personel kurang dari 2 (dua) orang.
- (6) Keharusan memperhatikan kedekatan disiplin ilmu dalam proses penggabungan antar spesialisasi medis.
- (7) Pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam setiap kelompok gabungan yang dituangkan dalam kebijakan resmi rumah sakit.
- (8) Opsi pembentukan hanya 2 (dua) kelompok besar yaitu Kelompok Bedah dan Kelompok Non-Bedah pada kondisi jumlah dokter spesialis yang sangat terbatas.
- (9) Pengelompokan dokter yang melakukan tindakan operatif ke dalam Kelompok Bedah dan dokter dengan tindakan non-operatif ke dalam Kelompok Non-Bedah.
- (10) Fleksibilitas bagi dokter umum untuk membentuk kelompok mandiri atau bergabung dengan kelompok tenaga medis tempat mereka bertugas.
- (11) Izin penggabungan dokter gigi ke dalam kelompok mandiri, kelompok bedah, atau kelompok dokter umum sesuai dengan jumlah personel yang tersedia.
- (12) Penegasan bahwa seluruh bentuk penggabungan harus diikuti dengan prosedur pelayanan medis yang terdokumentasi secara formal.

Pasal 24

Penempatan Kelompok Tenaga medis

- (1) Penetapan penempatan setiap dokter ke dalam kelompok tenaga medis melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit yang resmi.
- (2) Proses pengusulan penempatan dokter yang dilakukan oleh Ketua Komite Medis sebagai dasar pertimbangan direksi.
- (3) Pelengkapan Surat Keputusan dengan dokumen perjanjian kerja bagi masing-masing dokter yang bersangkutan.
- (4) Penjaminan kejelasan tugas dan batasan tanggung jawab setiap personel medis dalam struktur organisasi.
- (5) Pendefinisian fungsi dan wewenang klinis secara tertulis guna menghindari tumpang tindih peran dalam pelayanan.
- (6) Penguatan aspek legalitas praktik dokter di lingkungan rumah sakit melalui administrasi penempatan yang terpadu.

Pasal 25

Pemilihan Ketua Kelompok Tenaga medis

- (1) Kepemimpinan setiap kelompok tenaga medis oleh seorang ketua yang dipilih secara demokratis oleh para anggotanya.
- (2) Keanggotaan kelompok yang dapat terdiri dari perpaduan dokter purna waktu maupun dokter paruh waktu.
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pemilihan ketua kelompok di bawah koordinasi dan aturan yang disusun oleh Komite Medis.
- (4) Keterlibatan aktif Direktur Rumah Sakit dalam seluruh proses pemilihan guna menjaga keselarasan manajemen.
- (5) Pengesahan status ketua kelompok terpilih melalui penerbitan Surat Keputusan resmi dari Direktur Rumah Sakit.
- (6) Ketentuan masa bakti kepemimpinan kelompok tenaga medis selama minimal 3 (tiga) tahun dalam satu periode.
- (7) Pemberian kesempatan bagi ketua kelompok untuk dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya secara berturut-turut.
- (8) Penjaminan keberlanjutan organisasi melalui proses regenerasi kepemimpinan yang teratur dan transparan.

Pasal 26

Tujuan dan Fungsi Kelompok Tenaga medis

- (1) Penyusunan uraian tugas secara mendetail bagi seluruh anggota tenaga medis yang berada di bawah kepemimpinannya.
- (2) Perumusan batasan wewenang klinis yang jelas untuk menjamin keamanan praktik kedokteran dalam kelompok.
- (3) Penetapan tata kerja dan alur koordinasi internal tenaga medis guna meningkatkan efisiensi pelayanan.
- (4) Penentuan uraian tugas dan wewenang yang ditetapkan secara spesifik dan bersifat individu bagi masing-masing dokter.
- (5) Penjaminan bahwa setiap anggota memahami fungsi dan peran unik mereka di dalam struktur kelompok tenaga medis.
- (6) Sinkronisasi uraian tugas individu dengan standar pelayanan medis yang berlaku di rumah sakit.



Pasal 27

Hubungan Kerja Kelompok Tenaga medis

- (1) Pelaksanaan tanggung jawab administratif secara struktural kepada Direktur Rumah Sakit dan Kepala Bidang Pelayanan.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab fungsional profesi kepada Komite Medis sebagai otoritas tertinggi aspek klinis.
- (3) Penyelenggaraan koordinasi laporan profesi yang dilakukan melalui perantara Ketua Kelompok Tenaga medis.
- (4) Pemisahan jalur pelaporan antara urusan manajerial operasional dengan urusan etika serta mutu profesi.
- (5) Penjaminan akuntabilitas kinerja tenaga medis baik dari sisi kedisiplinan pegawai maupun standar praktik kedokteran.
- (6) Perwujudan tata kelola rumah sakit yang baik melalui pola pertanggungjawaban yang jelas dan terukur.

Pasal 28

Penilaian Kinerja

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja administratif oleh Direktur Rumah Sakit yang mencakup aspek disiplin kepegawaian dan motivasi kerja.
- (2) Penyelenggaraan evaluasi keprofesian secara mandiri oleh Komite Medis melalui instrumen audit medis dan peer review.
- (3) Pengawasan disiplin dan etika profesi yang dilakukan secara sistematis oleh Komite Medis untuk menjaga standar pelayanan.
- (4) Penempatan tenaga medis pada unit tertentu secara fungsional dengan tetap berada di bawah binaan profesional Komite Medis.
- (5) Tanggung jawab penuh Komite Medis terhadap pembinaan masalah etik, mutu klinis, serta pengembangan ilmu bagi seluruh tenaga medis.
- (6) Koordinasi aspek administratif harian tenaga medis di unit kerja yang berada di bawah kendali Kepala Instalasi terkait.
- (7) Perwujudan sistem evaluasi dua arah yang menyeimbangkan kepatuhan manajerial dengan keunggulan kualitas profesi.

Pasal 29

Tugas dan Fungsi Tenaga medis

- (1) Pelaksanaan fungsi utama sebagai penyedia pelayanan medis, pusat pendidikan, serta sarana pelatihan bagi tenaga kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan di bidang kedokteran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan profesi yang mencakup seluruh prosedur diagnosis, pengobatan, dan pencegahan komplikasi penyakit.
- (4) Penjalankan upaya peningkatan derajat kesehatan serta pemulihan kondisi pasien secara komprehensif.
- (5) Pengembangan kemampuan profesi secara mandiri maupun kolektif melalui program pendidikan berkelanjutan (Continuing Professional Development).
- (6) Penjaminan kualitas pelayanan agar tetap selaras dengan standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran.
- (7) Penyusunan dan pengumpulan data klinis sebagai dasar analisis pemantauan kualitas asuhan medis.
- (8) Pembuatan laporan pemantauan indikator mutu klinik secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan.



Pasal 30
Kewenangan Tenaga medis

- (1) Penyusunan rincian kewenangan klinis bagi setiap anggota tenaga medis yang dilakukan secara saksama oleh Ketua Kelompok Tenaga medis.
- (2) Proses pengusulan draf kewenangan klinis kepada Direktur Rumah Sakit melalui rekomendasi resmi dari Ketua Komite Medis.
- (3) Formalisasi kewenangan klinis setiap dokter ke dalam bentuk Surat Keputusan Direktur yang sah dan mengikat secara hukum.
- (4) Penjaminan akuntabilitas profesi melalui sinkronisasi antara keahlian dokter dengan tugas yang diberikan oleh rumah sakit.
- (5) Penguatan aspek legalitas dalam pelayanan medis melalui pendokumentasian kewenangan yang terstruktur dan terverifikasi.

Pasal 31
Tanggung Jawab Tenaga medis

- (1) Pemberian rekomendasi penempatan dokter baru kepada Direktur melalui Ketua Komite Medis dan Sub Komite Kredensial.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kinerja praktik dokter secara komprehensif menggunakan metode peer review serta audit medis.
- (3) Penjaminan mutu pelayanan melalui integrasi hasil evaluasi ke dalam program quality improvement rumah sakit.
- (4) Pemberian masukan teknis kepada Direktur sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan penempatan atau pengangkatan kembali dokter.
- (5) Penyelenggaraan program pengembangan profesional berkelanjutan atau Continuing Professional Development (CPD) bagi seluruh anggota.
- (6) Penyampaian aspirasi dan informasi terkini mengenai perkembangan ilmu serta teknologi kedokteran kepada manajemen.
- (7) Pemutakhiran standar operasional prosedur (SOP) dan dokumen klinis lainnya secara berkala sesuai perkembangan kondisi medis.
- (8) Penguatan etika profesi melalui pengawasan rutin terhadap perilaku klinis seluruh tenaga medis di lingkungan kelompok.

Pasal 32
Kewajiban Tenaga medis

- (1) Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) bidang administrasi dan manajerial di bawah koordinasi Direktur Rumah Sakit yang mencakup pengaturan tugas di rawat jalan, rawat inap, jadwal jaga, unit intensif, kamar operasi, hingga kamar bersalin.
- (2) Pengaturan mekanisme kerja operasional seperti jadwal visite, sistem shift, prosedur konsultasi, serta penyelenggaraan pertemuan klinik untuk pembahasan kasus kematian, kasus sulit, maupun kasus langka.
- (3) Penyusunan SPO pelayanan medis bidang keilmuan oleh Kelompok Tenaga medis di bawah koordinasi Komite Medis yang meliputi protokol pemeriksaan, penatalaksanaan, dan pemeriksaan penunjang untuk minimal 10 jenis penyakit.
- (4) Penetapan minimal 3 jenis indikator mutu klinis berbasis output atau outcome oleh setiap Kelompok Tenaga medis sebagai standar evaluasi pelayanan.
- (5) Pembuatan uraian tugas serta batasan kewenangan klinis secara spesifik bagi setiap anggota tenaga medis..
- (6) Pemberian pelayanan medis yang wajib berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan, dan SPO yang berlaku sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

- (7) Pelaksanaan rujukan kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis lain yang memiliki keahlian lebih tinggi apabila ditemukan keterbatasan dalam pemeriksaan atau pengobatan.
- (8) Penjagaan kerahasiaan seluruh data dan informasi medis pasien secara mutlak bahkan setelah pasien meninggal dunia.
- (9) Pemberian pertolongan darurat berdasarkan prinsip perikemanusiaan selama belum ada petugas lain yang mampu melakukannya.
- (10) Pengembangan kompetensi diri melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan pemantauan perkembangan teknologi kedokteran terbaru.
- (11) Penunjukan tenaga medis pengganti dengan keahlian yang setara saat berhalangan hadir dengan kewajiban memberikan konfirmasi kepada pasien.
- (12) Pemberian penjelasan informasi secara komprehensif kepada pasien sebagai dasar persetujuan tindakan medis atau informed consent.
- (13) Pembuatan rekam medis yang akurat dengan mematuhi seluruh petunjuk pelaksanaan dokumentasi medis.
- (14) Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya dalam setiap proses pelayanan pasien.
- (15) Kepatuhan penuh terhadap kebijakan penggunaan obat serta daftar formularium resmi yang ditetapkan oleh rumah sakit.

BAB VI KEPENGAWASAN

Pasal 33 Kepengawasan

- (1) Evaluasi kinerja praktik dokter dilakukan melalui mekanisme peer review, audit medis, serta program quality improvement secara berkala.
- (2) Kelompok Tenaga medis bertanggung jawab memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit mengenai seluruh aspek praktik kedokteran.
- (3) Rekomendasi mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi medis terbaru, serta penyampaian temuan klinis terkini.
- (4) Sinergi antara tenaga medis dan manajemen memastikan pelayanan kesehatan dijalankan berdasarkan standar medis yang berlaku dan bukti ilmiah terbaru.

Pasal 34 Ketentuan Perubahan

- (1) Perubahan atau penambahan Peraturan Internal Tenaga medis dilakukan melalui rapat khusus antara PT Disa Prima Medika (atau perwakilannya) dengan Direksi Rumah Sakit.
- (2) Mekanisme perubahan dan penambahan peraturan tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis yang ditetapkan pada saat rapat khusus diselenggarakan.

BAB VII KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS

Pasal 35 Kerahasiaan Pasien

- (1) Setiap pegawai rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi mengenai pasien.
- (2) Pemberian informasi medis terkait kerahasiaan pasien hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direktur atau Kepala Bidang Pelayanan.

- (3) Akses terhadap data medis pasien dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi pasien akan dikenakan sanksi sesuai peraturan internal rumah sakit.

Pasal 36
Informasi Medis

- (1) Hak pasien mengacu sepenuhnya pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Setiap pasien berhak menerima informasi medis yang jujur dan benar mencakup keadaan kesehatan terkini.
- (3) Penjelasan mengenai rencana terapi serta berbagai alternatif tindakan medis yang tersedia wajib disampaikan kepada pasien.
- (4) Informasi harus mencakup manfaat dan risiko dari setiap alternatif tindakan yang akan diambil.
- (5) Pasien berhak mengetahui prognosis serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi selama masa perawatan.

Pasal 37
Hak dan Kewajiban Pasien

- (1) Hak pasien meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
 - b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
 - c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
 - d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
 - e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
 - f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain;
 - g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (2) Kewajiban Pasien meliputi :
 - a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 38
Hak dan Kewajiban Tenaga Medis

- (1) Hak Tenaga Medis:
 - a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
 - b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
 - c. Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;



- e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Tenaga medis dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan dan perundungan.

(2) Kewajiban Tenaga Medis meliputi :

- a. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. Memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. Menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. Merujuk Pasien ke Tenaga Medis lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 39

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

(1) Hak Rumah Sakit meliputi:

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menetapkan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
- d. Menerima bantuan atau hibah dari pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Melakukan tuntutan hukum/menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian bagi Rumah Sakit.
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- g. Mempromosikan layanan kesehatan secara jujur dan informatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Rumah Sakit meliputi:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- b. Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien.



- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien tanpa meminta uang muka terlebih dahulu.
- d. Melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas untuk pasien tidak mampu, pelayanan korban bencana, dan misi kemanusiaan lainnya.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang layak, termasuk ruang ibadah, parkir, ruang tunggu, serta fasilitas ramah disabilitas, lansia, anak, dan ibu menyusui.
- f. Menyelenggarakan rekam medis secara elektronik dan terintegrasi sesuai standar nasional.
- g. Melaksanakan sistem rujukan yang terpadu dan efisien.
- h. Menolak permintaan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, etika, dan peraturan perundang-undangan.
- i. Menghormati, melindungi, dan memberikan informasi yang jelas mengenai hak serta kewajiban pasien.
- j. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws).
- k. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi seluruh petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- l. Menyelenggarakan sistem pencegahan kecelakaan, penanggulangan bencana, dan keselamatan kerja.
- m. Mendukung dan melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik skala regional maupun nasional.
- n. Membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik di Rumah Sakit.
- o. Menetapkan seluruh area Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok dan bebas asap rokok.

BAB VII KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR

Pasal 40

- (1) Kebijakan merupakan regulasi tertinggi di rumah sakit yang diikuti oleh Pedoman atau Panduan dan selanjutnya Standar Prosedur Operasional sebagai acuan utama pelaksanaan kegiatan.
- (2) Proses evaluasi dan persetujuan ulang dokumen regulasi dilakukan minimal setiap 3 tahun sekali atau jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengendalian dokumen menjamin bahwa hanya kebijakan dan prosedur versi terkini yang tersedia di unit pelaksana melalui mekanisme dokumen terkendali.
- (4) Identifikasi terhadap perubahan regulasi dilakukan oleh unit pelaksana secara berjenjang sesuai dengan hierarki struktural organisasi.
- (5) Dokumen regulasi harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan diakses oleh pelaksana untuk menjamin kelancaran operasional di lapangan.
- (6) Retensi dokumen regulasi yang sudah tidak berlaku mengacu pada Keputusan Direktur mengenai Retensi dan Penyusutan Arsip Non Rekam Medis.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan Internal Tenaga medis (Medical Staff By Laws) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, seluruh ketentuan internal yang mengatur tenaga medis di Rumah sakit prima husada yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Seluruh tenaga medis wajib menyesuaikan diri dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini secara penuh dan bertanggung jawab.

Pasal 42
Penyesuaian dan Transisi

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam kebijakan, pedoman, atau Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit.
- (2) Dalam masa transisi, seluruh proses pelayanan medis tetap berjalan dengan mengacu pada prinsip keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian terhadap kebijakan, sistem, dan prosedur yang telah berjalan dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan kepada pasien.

Pasal 43
Evaluasi dan Perbaikan

- (1) Peraturan ini dapat dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali sesuai kebutuhan rumah sakit dan/atau perubahan regulasi perundang-undangan.
- (2) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi dapat menjadi dasar perubahan atau penyempurnaan *Medical Staff By Laws*

Pasal 44
Ketentuan Penutup Umum

- (1) Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola rumah sakit.
- (2) Seluruh unit kerja dan tenaga medis wajib mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam Medical Staff By Laws ini dengan penuh tanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 20 Desember 2024

Mengetahui,
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Mengesahkan,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah